

Le cancer du sein: évaluation

Cycle de formation EE/TCEM 2025

Dr Khaled Trigui

1. Les trois principaux sites de métastase lymphatique lors d'un cancer du sein sont:

A. Les adénopathies axillaires

B. Les adénopathies mammaires internes

C. Les adénopathies sous claviculaires

D. Les adénopathies sus claviculaires

E. Les adénopathies intra-mammaires

2. Le drainage du quadrant supéro-interne du sein se fait essentiellement vers:

A. La voie axillaire

B. La voie mammaire para sternale

C. La voie sus claviculaire

D. La voie mammaire externe

E. La voie intra mammaire

3. Les adénocarcinomes primitifs invasifs du sein

- A. Sont de type spécifique dans la majorité des cas
- B. Sont accessibles au dépistage quel que soit leur type histologique
- C. Sont lymphophiles quel que soit leur type histologique
- D. Peuvent naître à partir du tissu conjonctif
- E. Ont le potentiel de récurrence le plus important parmi les tumeurs malignes du sein

4. Le cancer du sein

- A. Se présente sous forme de nodule bien circonscrit dans 2/3 des cas
- B. Est dit multicentrique en cas de foyers multiples dans des quadrants différents du même sein
- C. Est souvent bilatéral dans les formes évoluées
- D. Est bilatéral dans 15% des cas
- E. Est d'emblée métastatique dans les formes multicentriques

5. Le carcinome canalaire in situ:

- A. Est lymphophile
- B. Donne fréquemment une atteinte multicentrique
- C. Peut donner une maladie de Paget
- D. Évolue rarement vers un cancer invasif si non traité
- E. Peut coexister avec un carcinome invasif

6. Le carcinome lobulaire in situ:

- A. Est Bilatéral dans 20-30% des cas
- B. S'imprègne au dépistage
- C. Est un cancer de bon pronostic
- D. Sa prise en charge repose sur l'exérèse chirurgicale et la surveillance
- E. Est généralement découvert fortuitement

7. Le carcinome lobulaire invasif se diffère du carcinome canalaire invasif par:

A. Son caractère bilatéral plus fréquent

B. Sa tendance à former des foyers multiples

C. Son faible potentiel métastatique ganglionnaire

D. Sa faible cohésion intercellulaire

E. Sa fréquence plus élevée

8. Le carcinome infiltrant de type non spécifique

A. Ne donne de maladie de Paget que lorsqu'il est palpable

B. Est lymphophile

C. Est le type histologique le plus fréquent des tumeurs malignes du sein

D. Est souvent unilatéral

E. Est dépistable

9. Le comédocarcinome dans le cancer du sein:

- A. Est un facteur de mauvais pronostic
- B. S'associe à la composante lobulaire in situ
- C. Se traduit radiologiquement par des microcalcifications
- D. Sa présence est un signe de forme évoluée
- E. Se manifeste par un écoulement mamelonnaire

10. L'apparition d'une adénopathie suspecte homolatérale après le traitement d'un CCIS implique:

A. Une relecture histologique de la pièce opératoire

B. Un bilan d'extension

C. Un contrôle radiologique par écho-mammographie

D. Une IRM mammaire

E. Un prélèvement de l'adénopathie pour examen histologique

11. La tumeur phyllode maligne:

- A. Nait à partir de l'épithélium des canaux galactophores
- B. Présente un haut risque de récidence
- C. Est lymphophile
- D. Est une indication à la radiothérapie
- E. Est une contre-indication au traitement conservateur

12. Le cancer du sein d'origine génétique:

- A. Est fréquent après la ménopause
- B. Est dû au gène BRCA1 ou 2
- C. Peut s'associer à un cancer de l'ovaire synchrone
- D. Exprime fréquemment les récepteurs hormonaux
- E. Est de mauvais pronostic

13. L'examen clinique des seins :

A. Doit être bilatéral et comparatif

B. Inclut les aires ganglionnaires axillaires

C. Comporte deux temps

D. Exclut un cancer en cas d'absence de signes de malignité

E. Contribue à la classification TNM

14. Les signes cliniques de malignité lors d'un examen du sein:

- A. Un aspect en peau d'orange localisé
- B. Un écoulement unipore sanguinolant
- C. Une rétraction mamelonnaire récente
- D. Un nodule douloureux à la palpation
- E. Un ganglion axillaire mou

15. Les signes mammographiques de malignité sont:

- A. Une image hétérogène à centre dense
- B. Les microcalcifications
- C. La distorsion architecturale de la glande mammaire
- D. les microkystes
- E. L'épaississement cutané

16. Un nodule du sein classé ACR4 en échographie nécessite :

- A. Un contrôle échographique après un an
- B. Un complément de mammographie
- C. Une vérification histologique
- D. Un contrôle écho-mammographique après 6 mois
- E. Une IRM mammaire

17. Une lésion ACR6 :

- A. Est une indication de complément d'exploration par IRM
- B. Nécessite un bilan d'extension
- C. Peut prendre l'aspect d'une opacité régulière
- D. Est une indication de chimiothérapie
- E. Est souvent associée à une adénopathie palpable

18. Devant une suspicion clinique de malignité d'un nodule du sein, l'échographie mammaire:

- A. N'est indiquée que si la femme est jeune
- B. Permet de redresser le diagnostic de malignité
- C. Est indispensable dans tous les cas
- D. Permet de guider une biopsie du nodule
- E. Doit explorer le creux axillaire

19. Une patiente a eu une biopsie mammaire, montrant deux foyers de carcinome lobulaire invasif, votre conduite à tenir initiale sera:

A. Intervention de Patey du sein droit

B. IRM mammaire

C. Chimiothérapie première

D. Scanner thoraco-abdominopelvien

E. Scintigraphie osseuse

20. L'IRM mammaire est indiquée :

- A. En cas de carcinome lobulaire invasif
- B. En cas de suspicion de récurrence
- C. De première intention en cas de signes inflammatoires mammaires
- D. Pour le dépistage pour une femme de 40 ans présentant une mutation du gène BRCA1
- E. En cas de cancer métastatique

21. Un cancer du sein Luminal B comporte les éléments suivants:

A. RH-/Her+/Ki67 15%

B. RH-/Her -/Ki67 34%

C. RH+/Her-/Ki67 14%

D. RH+/Her+/Ki67 24%

E. RH+/Her-/Ki67 28%

22. Le traitement d'un cancer canalaire infiltrant T2N1M0 de 4 cm, RH+,Her+ chez une femme de 42 ans comporte:

- A. Une chimiothérapie première
- B. Une mastectomie première
- C. Une radiothérapie locale et régionale
- D. Une castration chimique
- E. Le Trastuzumab

23. Un cancer du sein T4c de 5 cm indique:

A. Une chimiothérapie néoadjuvante

B. Un traitement conservateur est possible si réduction tumorale

C. Une radiothérapie locale et régionale

D. Une intervention de Patey en première intention

E. Une chimiothérapie adjuvante systématique

24. Pour un CLI multicentrique et unilatéral, N1, le traitement consiste en :

A. Une intervention de Patey

B. Une chimiothérapie première pour réduction tumorale en vue d'un traitement conservateur

C. Une radiothérapie post opératoire

D. Une mastectomie

E. Une thérapeutique ciblée si Her +

25. Un carcinome canalaire in situ de 4,5 cm est traité par:

- A. Une tumorectomie
- B. Une radiothérapie post opératoire
- C. Un prélèvement de ganglion sentinelle
- D. Une chimiothérapie
- E. Une mastectomie

26. La maladie de Paget du mamelon associée à un carcinome intracanalair de 1,5cm:

- A. Impose une mastectomie**
- B. Impose un curage axillaire
- C. Nécessite une irradiation post opératoire
- D. Est classée T4b
- E. Indique un bilan d'extension à distance

27. Vous proposez à une femme de 42 ans ayant une sœur de 25 ans atteinte de cancer du sein et présentant une mutation BRCA1:

A. Un dépistage par IRM mammaire

B. Un conseil génétique

C. Un dépistage par mammographie

D. Un examen clinique des seins

E. Un dépistage par mammographie à partir de l'âge de 45 ans

28. La technique du ganglion sentinelle dans la prise en charge d'un cancer du sein:

A. Est indiquée en cas de cancer classé T1N0M0

B. A un objectif curatif

C. Sa positivité impose une lymphadénectomie axillaire

D. Se fait idéalement par un double marquage

E. Est contre indiquée au cours de la grossesse

29. Le traitement d'un carcinome non spécifique du sein type triple négatif, de 2.5cm, T2N1M0 consiste en :

A. Une chimiothérapie néoadjuvante

B. Une intervention de Patey

C. Une tumorectomie élargie

D. Une radiothérapie post opératoire

E. Un curage ganglionnaire axillaire

30. Les facteurs de risque de récurrence d'un cancer du sein :

A. Le traitement conservateur

B. Les tumeurs T3

C. Le type moléculaire Luminal A

D. L'atteinte ganglionnaire

E. la taille tumorale < 2 cm

31. Le traitement hormonal par le tamoxifène pour le cancer du sein :

A. Est de durée minimale de 5 ans

B. Induit une hyperplasie de l'endomètre

C. N'a pas de place chez les femmes ménopausées

D. Est contre indiqué en cas forme métastatique

E. Inhibe la synthèse des œstrogènes